Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AUFKLÄRUNGS- UND EINWILLIGUNGSBOGEN

Rhinoplastik

Ästhetische Nasenkorrektur (bei Bedarf kombiniert mit einer Korrektur der Nasenatmung)

Liebe Patientin, lieber Patient, dieser Bogen soll Ihnen in **einfacher und verständlicher Sprache** erklären, was Sie über den Ihnen empfohlenen Eingriff wissen sollten. Er soll Ihnen keine Angst machen, sondern Ihnen helfen, Ihre Entscheidung **frei und gut informiert** zu treffen.

Bitte lesen Sie diesen Bogen in Ruhe durch. Fragen Sie Ihren Arzt nach allem, was Sie nicht verstehen. Ihr Arzt wird Ihnen außerdem mündlich die Risiken erläutern, die speziell in Ihrer Situation bestehen. Ob Sie Ihre Einwilligung geben oder nicht, ist allein Ihr Recht.

ANGABEN ZU PATIENT/IN UND EINGRIFF

Vor- und Nachname: _____ Geburtsdatum: _____

Reisepass- / Ausweisnummer: _____ Akten- / Protokollnummer: _____

Telefon: _____ Datum der Aufklärung: _____

Geplantes Datum des Eingriffs: _____

Bogen erstmals an Patient/in übermittelt (Datum / E-Mail, WhatsApp, persönlich): _____

Durchführender und aufklärender Arzt: **Op. Dr. Murat Ayata**

Krankenhaus / Einrichtung, in der der Eingriff durchgeführt wird: _____

Geplante Technik: ☐ Offene Technik ☐ Geschlossene Technik ☐ Entscheidung durch den Operateur während der Operation

Gleichzeitig durchzuführende Eingriffe: ☐ Septumplastik ☐ Verkleinerung der Nasenmuscheln ☐ Keine _____

Entnahmestelle für Knorpeltransplantat: ☐ Nasenscheidewand (Septum) ☐ Ohr ☐ Rippe ☐ Voraussichtlich nicht erforderlich _____

Anliegen und Erwartungen der Patientin / des Patienten: _____

1 Ihre Erkrankung und das Ziel des Eingriffs

Die Rhinoplastik ist eine Operation, bei der die äußere Form der Nase neu gestaltet wird (Nasenrücken, Höcker, Nasenspitze, Nasenbreite, Nasenlöcher sowie ihre Harmonie mit dem Gesicht). Liegen eine die Atmung behindernde Verkrümmung der Nasenscheidewand (Septumdeviation), ein Einfallen der Nasenflügel oder vergrößerte Nasenmuscheln vor, können diese in derselben Operation korrigiert werden.

Die Form der Nase beruht auf angeborenen Merkmalen, auf Veränderungen während des Wachstums oder auf früheren Verletzungen (Schlag, Bruch). Diese Strukturen verändern sich nicht von selbst. Ziel der Operation ist es, die gemeinsam vereinbarten **realistischen Ziele** zu erreichen und eine Nase zu erhalten, die **natürlich wirkt, zu Ihrem Gesicht passt und eine freie Atmung ermöglicht**.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Wie wird der Eingriff durchgeführt?

Die Operation wird in Vollnarkose im Operationssaal durchgeführt. Vor der Operation wird Ihre Nase untersucht und fotografiert, und die Planung wird gemeinsam mit Ihnen erstellt.

1. **Schnittführung:** Bei der geschlossenen Technik liegen alle Schnitte im Naseninneren, von außen ist keine Narbe sichtbar. Bei der offenen Technik wird zusätzlich ein kleiner Schnitt von etwa 4–5 mm über den schmalen Hautsteg zwischen den Nasenlöchern (Kolumella) gesetzt; diese Narbe wird mit der Zeit meist kaum noch wahrnehmbar.
2. **Formung des Nasengerüsts:** Haut und Weichteile werden behutsam abgelöst. Ist ein Höcker vorhanden, wird er an Knochen und Knorpel abgetragen oder mit Techniken korrigiert, die den Nasenrücken erhalten (Preservation-Techniken). Die Knorpel der Nasenspitze werden mit Nähten neu geformt.
3. **Verschmälern/Begradigen der Knochen (Osteotomie):** Müssen breite oder schiefe Nasenbeine verschmälert oder begradigt werden, werden kontrollierte Knochenschnitte durchgeführt. Dieser Schritt kann die Wahrscheinlichkeit von Blutergüssen und Schwellungen erhöhen.
4. **Stützen und Transplantate:** Damit die Nase ihre Form langfristig behält und die Atemwege offen bleiben, werden bei Bedarf Knorpelstützen (Transplantate) eingesetzt. Der Knorpel wird zunächst aus dem Naseninneren (Septum) entnommen; reicht dieser nicht aus, kann Ohr- oder Rippenknorpel verwendet werden. Dies wird vor der Operation mit Ihnen besprochen.
5. **Funktionelle Korrektur:** Falls notwendig, wird die Nasenscheidewand (Septum) begradigt und die Nasenmuscheln werden verkleinert.
6. **Wundverschluss und Schiene:** Die Schnitte werden mit feinen Nähten verschlossen. Auf den Nasenrücken wird eine Schutzschiene gelegt; bei Bedarf werden weiche Silikonschienen oder Tamponaden, die das Atmen ermöglichen, in die Nase eingelegt.

BETÄUBUNG (ANÄSTHESIE)	VORAUSSICHTLICHE DAUER	KRANKENHAUSAUFENTHALT / ENTLASSUNG
Vollnarkose	Etwa 2–4 Stunden	In der Regel eine Nacht im Krankenhaus

3 Erwarteter Nutzen und Erfolgsaussichten

- Eine natürlichere, ausgewogenere und besser zu Ihrem Gesicht passende Nasenform
- Beseitigung einer gegebenenfalls bestehenden Nasenatmungsbehinderung und leichteres Atmen
- Ein Beitrag dazu, dass Sie sich wohler fühlen

Die meisten Patientinnen und Patienten sind mit dem Ergebnis zufrieden. Die Nase liegt jedoch in der Mitte des Gesichts und braucht lange, um auszuheilen; das endgültige Ergebnis zeigt sich innerhalb von **12–18 Monaten**. In Fachveröffentlichungen wird berichtet, dass bei etwa **5–15 %** der Patientinnen und Patienten eine kleinere oder umfangreichere Korrekturoperation (Revision) notwendig werden kann. Bei Nasen mit dicker Haut, nach Voroperationen oder nach schweren Verletzungen ist das Ergebnis schwerer vorherzusagen.

4 Andere Behandlungsmöglichkeiten

- **Keine Operation:** Da es sich um einen ästhetischen Eingriff handelt, haben Sie stets die Möglichkeit, ihn nicht durchführen zu lassen.
- **Formung der Nase mit Fillern („Nasenkorrektur ohne Operation"):** Kann einen kleinen Höcker oder eine Delle vorübergehend kaschieren; die Nase wird dadurch nicht kleiner, die Atmung verbessert sich nicht, und es bestehen eigene Risiken wie der Verschluss eines Blutgefäßes.
- **Nur funktionelle Operation (Septumplastik/Verkleinerung der Nasenmuscheln):** Ist ausschließlich die Atmung das Problem, kann dies ohne Veränderung der äußeren Nasenform erfolgen.
- **Medikamentöse Behandlung:** Nasensprays können bei einer Verstopfung durch Allergie oder Schleimhautschwellung helfen; strukturelle Fehlstellungen korrigieren sie nicht.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

5 Was geschieht, wenn der Eingriff nicht durchgeführt wird?

Wird die Operation nicht durchgeführt, bleibt die jetzige Form Ihrer Nase unverändert. Haben Sie Atembeschwerden mit struktureller Ursache (Verkrümmung, Einfallen der Nasenflügel), bessern sich diese nicht von selbst, stellen aber in der Regel keine akute Gefahr für Ihre Gesundheit dar.

Sie haben das Recht, den empfohlenen Eingriff abzulehnen, ihn zu verschieben oder eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Diese Entscheidung hat keinerlei Einfluss auf andere medizinische Leistungen, die Ihnen angeboten werden. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen; bitte beachten Sie jedoch, dass es nach Beginn eines Eingriffs Phasen geben kann, in denen ein Abbruch medizinisch nicht vertretbar wäre.

6 Vorbereitung auf den Eingriff

- Wenn Sie in den letzten 6–12 Monaten **Isotretinoin** (Aknemedikament, z. B. Roaccutan) eingenommen haben, teilen Sie uns dies bitte mit; es kann die Wundheilung der Haut beeinflussen, und der Operationszeitpunkt kann entsprechend geplant werden.
- Vor der Operation werden Blutuntersuchungen und bei Bedarf weitere Untersuchungen durchgeführt, und Sie werden vom Narkosearzt untersucht.
- Sie dürfen **6–8 Stunden** vor der Operation nichts essen und nichts trinken (bitte befolgen Sie die Anweisungen des Narkosearztes).
- Tragen Sie am Operationstag kein Make-up, keinen Nagellack, keinen Schmuck und keine Kontaktlinsen. Es empfiehlt sich, dass Sie am ersten Tag nach der Operation eine Angehörige oder einen Angehörigen bzw. eine Freundin oder einen Freund bei sich haben.
- Bei aktiver Akne oder einer Hautinfektion im Gesicht, bei Grippe oder einem Infekt der oberen Atemwege kann die Operation verschoben werden.
- Teilen Sie Ihrem Arzt **alle Medikamente** mit, die Sie einnehmen (einschließlich Blutverdünnern, Aspirin, Schmerzmitteln, Medikamenten zur Gewichtsabnahme und Hormonpräparaten), sowie alle **pflanzlichen Mittel und Nahrungsergänzungsmittel** (z. B. Omega-3, Vitamin E, Ginkgo, Knoblauch, Ginseng, Fischöl). Setzen Sie kein Medikament eigenmächtig ohne ärztlichen Rat ab.
- Informieren Sie uns unbedingt über **Allergien**, Blutungs- oder Gerinnungsstörungen, Herz- und Lungenerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck oder Schilddrüsenerkrankungen, frühere Operationen sowie über Probleme, die Sie bei früheren Narkosen hatten.
- Wenn Sie möglicherweise schwanger sind oder stillen, teilen Sie uns dies bitte vor dem Eingriff mit.
- Rauchen und Nikotinprodukte beeinträchtigen die Wundheilung erheblich. Hören Sie nach Möglichkeit mindestens 2–4 Wochen vor dem Eingriff damit auf und rauchen Sie während der Heilungsphase nicht.

7 Heilungsverlauf: Was Sie erwartet

Erste 48 Stunden	Eine verstopfte Nase, leichtes Nachsickern, Kopfschmerzen und eine Schwellung des Gesichts sind normal. Die Schmerzen sind meist leicht bis mäßig und lassen sich mit Schmerzmitteln gut behandeln. Schlafen mit erhöhtem Kopf und kühlende Kompressen helfen, die Schwellung zu verringern. **Falls** Blutergüsse auftreten, zeigen sie sich um die Augen und klingen in 7–10 Tagen ab.
1. Woche	Eventuell eingelegte Silikonschienen/Tamponaden in der Nase werden in der Regel am 2.–5. Tag entfernt, die äußere Schiene und die Fäden etwa am **7. Tag**. Sie werden gebeten, das Naseninnere mit Kochsalzlösung zu spülen. Die meisten Patientinnen und Patienten nehmen Bürotätigkeiten und ihr soziales Leben innerhalb von 7–10 Tagen wieder auf.
2.–6. Woche	Der größte Teil der Schwellung bildet sich zurück, die Nasenspitze kann sich jedoch noch fest und leicht taub anfühlen. Anstrengender Sport, Kontaktsportarten und Schwimmen sollten für etwa **4–6 Wochen** zurückgestellt werden. Eine Brille sollte mindestens **6 Wochen**

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

	lang nicht getragen werden, es sei denn, sie wird mit Pflaster so fixiert, dass sie nicht auf den Nasenrücken drückt.
3.–12. Monat	Die verbleibende Schwellung, besonders an der Nasenspitze, nimmt allmählich ab. Die Form der Nase verändert sich in dieser Zeit weiter; kleine Unregelmäßigkeiten, die anfangs sichtbar sind, verschwinden meist.
12.–18. Monat	Das endgültige Ergebnis wird sichtbar. Wird ein Korrektureingriff (Revision) für notwendig gehalten, erfolgt er in der Regel nach einer Wartezeit von mindestens 12 Monaten.

8 Mögliche Risiken und Komplikationen

Wie jeder medizinische Eingriff ist auch dieser Eingriff mit gewissen Risiken verbunden. Im Folgenden sind **zu erwartende vorübergehende Begleiterscheinungen** und **Komplikationen** getrennt aufgeführt und nach ihrer Häufigkeit geordnet. Die angegebenen Zahlen sind **ungefähre** Werte aus der medizinischen Fachliteratur; Ihr persönliches Risiko kann je nach Alter, allgemeinem Gesundheitszustand, Rauchen und früheren Operationen niedriger oder höher sein.

Die allermeisten Komplikationen sind **vorübergehend** und bessern sich bei angemessener Behandlung. Aufgeführt sind auch sehr seltene, aber schwerwiegende Ereignisse; dass sie hier stehen, bedeutet nicht, dass sie bei Ihnen auftreten werden, doch Sie sollten sie kennen, um eine informierte Entscheidung treffen zu können.

Zu erwartende, vorübergehende Begleiterscheinungen (keine Komplikationen – ein normaler Teil der Heilung)

- Verstopfte Nase, leichtes Nachsickern und blutig tingierte Absonderung (in den ersten Tagen)
- Schwellung des Gesichts und um die Augen; **falls** Blutergüsse auftreten, klingen sie innerhalb von 1–2 Wochen ab
- Vorübergehendes Taubheitsgefühl an der Nasenspitze und den Frontzähnen; Verhärtung der Nasenspitze
- Vorübergehend vermindertes Riechvermögen (bessert sich mit dem Abklingen der Schwellung)
- Die Form der Nase verändert sich über Monate weiter

Häufige Beschwerden (meist vorübergehend oder mit Behandlung rückläufig)

- **Länger anhaltende Schwellung** — Besonders bei dicker Haut kann die Schwellung der Nasenspitze ein Jahr oder länger anhalten. Bei Bedarf kann sie mit Kortisoninjektionen unterstützend behandelt werden.
- **Leichte Asymmetrie und kleine Unregelmäßigkeiten** — Da das Gesicht selbst nicht vollkommen symmetrisch ist, können geringe Unterschiede an der Nase bestehen bleiben; kleine Knochen-/Knorpelvorsprünge können tastbar, aber meist nicht sichtbar sein.
- **Notwendigkeit einer Revision (Korrektur)** — Bei etwa **5–15 von 100** Patientinnen und Patienten kann ein Korrektureingriff notwendig werden, der von einer kleinen Nachkorrektur bis zu einer umfangreicheren Operation reichen kann.
- **Krustenbildung und Trockenheit in der Nase** — In den ersten Wochen häufig; bessert sich mit regelmäßigem Spülen und Befeuchten.

Gelegentliche Beschwerden

- **Nasenbluten** — Bei etwa **1–3 von 100** Patientinnen und Patienten kann eine Blutung auftreten, die eine Tamponade oder einen Eingriff erfordert. Sehr selten muss die Blutung im Operationssaal gestillt werden.
- **Infektion** — Tritt bei **weniger als 1 bis 3 von 100** Patientinnen und Patienten auf. Sie heilt in der Regel mit Antibiotika ab; selten muss die Infektion entlastet (der Eiter abgeleitet) oder ein Transplantat entfernt werden.
- **Atmung bessert sich nicht wie erwartet** — Die Nasenatmungsbehinderung kann unvollständig zurückgehen oder selten sogar zunehmen; eine weitere Behandlung oder Operation kann notwendig werden.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Loch in der Nasenscheidewand (Perforation)** — Ein Loch in der Nasenscheidewand entsteht bei etwa **1 von 100** Patientinnen und Patienten. Oft verursacht es keine Beschwerden; führt es zu Pfeifgeräuschen, Krustenbildung oder Blutungen, kann eine Behandlung notwendig sein.
- **Blut- oder Eiteransammlung in der Nasenscheidewand (Hämatom / Abszess)** — Wird am Septum operiert, tritt dies bei **weniger als 1 von 100** Patientinnen und Patienten auf. Es äußert sich in den Tagen nach der Operation durch zunehmende Nasenatmungsbehinderung, Schmerzen und Fieber. Es muss **dringend entlastet** werden, um eine Schädigung des Nasenknorpels zu vermeiden; unbehandelt kann es zu Knorpelverlust und einem Einsinken des Nasenrückens (Sattelnase) kommen, deren Korrektur eine weitere Operation erfordern kann.
- **Verwachsungen in der Nase (Synechien)** — Gewebe im Naseninneren verkleben miteinander; behindern sie die Atmung, können sie mit einem einfachen Eingriff gelöst werden.
- **Auffällige Narbe** — Bei der offenen Technik kann die Narbe an der Kolumella selten sichtbar bleiben; werden die Nasenlöcher verkleinert, entsteht eine feine Narbe in der Nasenflügelfalte.
- **Länger anhaltendes Taubheitsgefühl** — Ein vermindertes Gefühl an der Nasenspitze oder den Frontzähnen kann mehrere Monate anhalten; selten kann es dauerhaft sein.
- **Probleme mit Transplantaten** — Knorpeltransplantate können sich mit der Zeit verschieben, verbiegen, sich teilweise zurückbilden oder sich unter der Haut abzeichnen. Wird Knorpel aus dem Ohr oder der Rippe entnommen, besteht an dieser Stelle ein Risiko für Schmerzen, Narbenbildung und Blutung und bei der Rippe sehr selten für eine Verletzung des Lungenfells (Pneumothorax).

Seltene oder sehr seltene, aber möglicherweise schwerwiegende Komplikationen

- **Hautprobleme** — Dünner werdende Haut, Rötung, kleine sichtbare Äderchen oder vermehrtes Narbengewebe bei dicker Haut. Sehr selten kann, vor allem bei Rauchern und voroperierten Nasen, eine Durchblutungsstörung der Haut zu einer Wunde und zu Gewebeverlust führen. In diesem Fall können eine langwierige Wundbehandlung und eine wiederherstellende Operation notwendig werden, und eine bleibende Narbe oder Formveränderung kann zurückbleiben.
- **Dauerhaft vermindertes oder verlorenes Riechvermögen** — Sehr selten.
- **Probleme mit dem Tränenkanal und Blutung um das Auge** — Sehr selten können die Knochenschnitte zu einem tränenden Auge oder einer Blutung um das Auge führen.
- **Austritt von Hirnwasser (Liquorleck), Hirnhautentzündung (Meningitis), Sehverlust** — Äußerst seltene Komplikationen, die in **weit weniger als 1 von 10.000** Fällen auftreten und durch eine Verletzung der dünnen Knochen entstehen, welche die Nase von der Schädelbasis und vom Auge trennen. Treten sie auf, können eine weitere Behandlung im Krankenhaus (manchmal auf der Intensivstation) und eine Operation notwendig werden; ein Sehverlust kann, falls er eintritt, dauerhaft sein.
- **Toxisches Schocksyndrom** — Eine sehr seltene, aber schwere Erkrankung im Zusammenhang mit Nasentamponaden (plötzliches hohes Fieber, Hautausschlag, niedriger Blutdruck), die eine sofortige Behandlung erfordert. Sie muss im Krankenhaus, manchmal auf der Intensivstation, behandelt werden und kann lebensbedrohlich sein.
- **Psychische Unzufriedenheit** — Trotz eines technisch gelungenen Ergebnisses kann es einem Menschen schwerfallen, sich an sein neues Aussehen zu gewöhnen. Ein offenes Gespräch über die Erwartungen vor der Operation verringert dieses Risiko.

Allgemeine Risiken jedes operativen / medizinischen Eingriffs

- **Narkoserisiken:** Wird eine Vollnarkose oder Sedierung (Dämmerschlaf) durchgeführt, erläutert Ihnen der Narkosearzt deren Risiken (Übelkeit, Halsschmerzen, Zahnschäden, allergische Reaktion und sehr selten Herz- oder Lungenprobleme) gesondert, und Ihre Einwilligung wird auf einem **separaten Narkose-Aufklärungsbogen** eingeholt.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Blutung und Bluttransfusion:** Eine Bluttransfusion ist bei diesen Eingriffen nur sehr selten erforderlich. Bei einer schweren Blutung können Blut oder Blutprodukte notwendig werden; diese bergen eigene, sehr seltene Risiken (z. B. Allergie oder Infektion).
- **Infektion:** Eine Wundinfektion nach der Operation wird in der Regel mit Antibiotika behandelt; selten kann eine Drainage (Ableiten des Eiters) notwendig sein.
- **Blutgerinnsel in den Beinvenen (Thrombose) und in der Lunge (Lungenembolie):** Bei kurzen Operationen im Kopf-Hals-Bereich sehr selten. Frühes Aufstehen und Gehen senkt das Risiko. Hormonpräparate, Rauchen, starkes Übergewicht und frühere Blutgerinnsel erhöhen das Risiko.
- **Medikamentenallergie:** Auf die verwendeten Medikamente, Desinfektionsmittel, Pflaster oder Nahtmaterialien kann eine allergische Reaktion auftreten.
- **Narbenbildung und Heilungsstörungen:** Wie Narben verheilen, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich; sehr selten kann sich eine verdickte (hypertrophe) Narbe oder ein Keloid bilden.
- **Lebensgefahr:** Todesfälle bei geplanten Operationen im Kopf-Hals-Bereich sind heute äußerst selten; dennoch ist kein operativer Eingriff völlig frei von Risiken. Eine schwere Komplikation kann eine Behandlung auf der Intensivstation erforderlich machen und zu einer bleibenden Behinderung führen.

Diese Aufstellung umfasst nicht jede denkbare Komplikation; andere unvorhersehbare und sehr seltene Ereignisse können auftreten. Tritt eine Komplikation auf, plant Ihr Arzt die notwendige Behandlung und Nachsorge; dies kann eine zusätzliche Behandlung, Medikamente, Eingriffe oder eine erneute Operation erfordern.

9 Wann Sie sich sofort bei uns melden sollten

- **Nasenbluten, das nicht aufhört oder sehr stark ist**, obwohl Sie einige Minuten lang Druck ausgeübt und Eis aufgelegt haben
- **Zunehmende Nasenatmungsbehinderung, starke Schmerzen und Schwellung der Nase** in den Tagen nach der Operation (kann ein Zeichen für ein Septumhämatom/einen Septumabszess sein)
- **Fieber über 38,5 °C**, zunehmende Schmerzen, Rötung oder übel riechende Absonderung aus der Nase
- **Plötzliches hohes Fieber, Hautausschlag, Schwindel oder Schwäche**, während Tamponaden in der Nase liegen
- **Klare, wässrige Absonderung** aus der Nase, besonders wenn sie beim Vorbeugen zunimmt; oder starke Kopfschmerzen und Nackensteifigkeit
- **Verschwommenes Sehen oder Doppelbilder** oder rasch zunehmende Schwellung und Schmerzen um das Auge
- Ein Schlag auf die Nase oder eine plötzliche Veränderung ihrer Form
- Atemnot oder Schmerzen in der Brust

Wenn eines dieser Anzeichen auftritt, rufen Sie unverzüglich Ihren Arzt an: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Wenn Sie uns nicht erreichen, suchen Sie die nächste Notaufnahme auf oder wählen Sie die 112 (Notrufnummer in der Türkei und in ganz Europa).

10 Hinweise zu Medikamenten und zum Alltag

- Schnäuzen Sie sich in den ersten 2 Wochen nicht; wenn Sie niesen müssen, niesen Sie mit offenem Mund.
- Reinigen Sie das Naseninnere so, wie es Ihnen gezeigt wurde, und so oft wie empfohlen.
- Vermeiden Sie mindestens 6 Wochen lang Stöße gegen die Nase, eine auf dem Nasenrücken aufliegende Brille und das Schlafen in Bauchlage.
- Schützen Sie die Haut Ihrer Nase mindestens 3 Monate lang vor der Sonne (Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor, Hut).
- Wenn Sie aus dem Ausland angereist sind, ist ein Flug in der Regel nach Entfernung der Schiene (etwa am 7. Tag) unbedenklich.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Nehmen Sie die Ihnen verordneten Medikamente (Antibiotika, Schmerzmittel usw.) in der empfohlenen Dosierung und für die empfohlene Dauer ein. Nehmen Sie Aspirin oder ähnliche Medikamente, die Blutungen verstärken können, nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt ein.
- Trinken Sie nach der Operation bei Flügen oder Reisen von mehr als 4 Stunden reichlich Wasser, bewegen Sie sich regelmäßig und tragen Sie, falls empfohlen, Kompressionsstrümpfe; dies senkt das Risiko von Blutgerinnseln in den Beinen.
- Während der Heilungsphase wird empfohlen, keinen Alkohol zu trinken und auf Rauchen und Nikotinprodukte zu verzichten.
- Bitte nehmen Sie alle Kontrolltermine wahr. Wenn Sie aus dem Ausland angereist sind, kann die Nachsorge nach Ihrer Rückkehr per Online-Sprechstunde und Fotos/Videos fortgeführt werden; falls Sie einen Arzt vor Ort aufsuchen müssen, erhalten Sie einen schriftlichen Operationsbericht und unsere Empfehlungen.

11 Unerwartete Befunde während des Eingriffs, Gewebeproben und Blutprodukte

Ergibt sich während des Eingriffs eine unvorhergesehene Situation, hält sich Ihr Arzt an den Umfang des Eingriffs, in den Sie mit diesem Bogen eingewilligt haben. **Sofern keine Lebensgefahr und keine Gefahr eines schweren Organschadens besteht**, wird kein zusätzlicher Eingriff vorgenommen, in den Sie nicht eingewilligt haben; in diesem Fall wird der Eingriff an einem sicheren Punkt beendet, und Sie werden anschließend informiert, damit die Entscheidung gemeinsam mit Ihnen getroffen werden kann. Besteht Lebensgefahr, wird die Notfallbehandlung durchgeführt, die zum Schutz Ihres Lebens oder des Organs erforderlich ist.

Während des Eingriffs entnommenes Gewebe wird, wenn nötig, zur Sicherung der Diagnose zur **feingeweblichen (pathologischen) Untersuchung** eingesandt. Je nach Ergebnis kann eine weitere Behandlung oder Nachsorge erforderlich sein.

Eine Bluttransfusion ist bei diesen Eingriffen nur sehr selten notwendig und wird nur verabreicht, wenn sie lebenswichtig ist. Wenn Sie Blut oder Blutprodukte ablehnen (zum Beispiel aus religiösen Gründen), müssen Sie uns dies vor dem Eingriff mitteilen; die möglichen Folgen dieser Entscheidung werden gesondert mit Ihnen besprochen und unter „Informationen speziell für Sie“ festgehalten.

12 Fotos, Bildaufnahmen und Ihre personenbezogenen Daten

Vor und nach dem Eingriff können zur Planung, Verlaufskontrolle und Beurteilung des Ergebnisses **Fotos/Videos** angefertigt werden. Diese Aufnahmen sind Teil Ihrer Krankenakte und werden vertraulich behandelt. Ihre Aufnahmen werden **niemals für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit oder soziale Medien verwendet.**

Für jeden anderen Zweck dürfen Ihre Aufnahmen **nur mit Ihrer gesonderten und ausdrücklichen Erlaubnis** verwendet werden. Eine Ablehnung hat keinerlei Einfluss auf Ihre Behandlung, und Sie können Ihre Erlaubnis jederzeit widerrufen:

☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Aufnahmen **ausschließlich für die medizinische Dokumentation und die Verlaufskontrolle der Behandlung** verwendet werden.

☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich nicht erkennbar bin** (Gesicht/Augenpartie abgedeckt).

☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich erkennbar sein kann**.

☐ Ich **erlaube keine** Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken / Ausbildungszwecken.

Ihre personenbezogenen Daten und Gesundheitsdaten werden nach dem türkischen Gesetz Nr. 6698 zum Schutz personenbezogener Daten (KVKK) und den einschlägigen gesundheitsrechtlichen Vorschriften zu Zwecken der Diagnose, der Behandlung und der Erfüllung gesetzlicher Pflichten von Personen verarbeitet, die der beruflichen Schweigepflicht unterliegen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren Datenschutzhinweisen.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

13 Informationen und Anmerkungen speziell für Sie (vom Arzt auszufüllen)

Patientenspezifische zusätzliche Risiken (Begleiterkrankungen, Medikamente, frühere Operationen), Einzelheiten der Planung, Erwartungen der Patientin / des Patienten, gestellte Fragen und gegebene Antworten. Gibt es nichts zu ergänzen, „keine" eintragen.

14 Erklärung der Patientin / des Patienten

- ☐ Ich habe diesen Bogen in meiner Sprache gelesen und verstanden. Ich hatte ausreichend Bedenkzeit, konnte Fragen stellen und habe zufriedenstellende Antworten erhalten.
- ☐ Meine Erkrankung, das Ziel des empfohlenen Eingriffs, wie, von wem und wo er durchgeführt wird, seine voraussichtliche Dauer, der erwartete Nutzen, die Erfolgsaussichten, die Alternativen und die möglichen Folgen, wenn er nicht durchgeführt wird, wurden mir mündlich und schriftlich erklärt.
- ☐ Die häufigen und die möglicherweise schwerwiegenden Risiken sowie die möglichen Folgen dieser Komplikationen (einschließlich der Möglichkeit, dass eine weitere Behandlung oder ein erneuter Eingriff bzw. eine erneute Operation notwendig wird) wurden mir erklärt. Mir ist bewusst, dass das Ergebnis eines medizinischen Eingriffs **nicht zu 100 % garantiert werden kann**.
- ☐ Ich habe zutreffende und vollständige Angaben zu meinem Gesundheitszustand, meinen Medikamenten, meinen Allergien und früheren Erkrankungen gemacht. Mir ist bewusst, dass unvollständige oder falsche Angaben die Risiken erhöhen können.
- ☐ Mir ist bewusst, dass die Befolgung der Anweisungen vor und nach dem Eingriff zum Ergebnis beiträgt und dass die Wahrnehmung der Kontrolltermine wichtig ist.
- ☐ Ich weiß, dass ich meine Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen kann. Mir ist bewusst, dass meine Unterschrift unter diesen Bogen den Arzt nicht von seiner Sorgfaltspflicht entbindet.
- ☐ Ich treffe diese Entscheidung aus freiem Willen und ohne Druck von irgendeiner Seite.
- ☐ Mir ist bewusst, dass der Vergleich meiner Fotos vor und nach der Operation Teil der Beurteilung des Ergebnisses ist und dass Computersimulationen oder Beispielfotos nur eine Vorstellung vermitteln sollen und kein Ergebnis garantieren.
- ☐ Mir ist bewusst, dass dieser Eingriff **ästhetischer Natur** ist, dass er medizinisch nicht notwendig ist und dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, ihn nicht durchführen zu lassen. Ich habe meine Erwartungen mit meinem Arzt besprochen, und das realistisch erreichbare Ergebnis wurde mir erklärt.
- ☐ Mir ist bewusst, dass weder eine vollkommene Symmetrie noch eine exakte Nachbildung des Aussehens auf einem Foto garantiert werden kann, dass das endgültige Ergebnis davon abhängt, wie mein Gewebe heilt, und dass in manchen Fällen ein Korrektureingriff notwendig sein kann.

- ☐ **Ich ERTEILE MEINE EINWILLIGUNG zu dem oben beschriebenen Eingriff.**
- ☐ **Den oben beschriebenen Eingriff LEHNE ICH AB. Die möglichen Folgen der Ablehnung wurden mir erklärt.**

Wir empfehlen, dass die Patientin / der Patient handschriftlich ergänzt: „Ich habe diesen Bogen gelesen und verstanden und willige ein."

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

15 Unterschriften

	VOR- UND NACHNAME	UNTERSCHRIFT	DATUM / UHRZEIT
Patient/in			
Gesetzliche/r Vertreter/in (Elternteil / Vormund) – Verhältnis zum Patienten:			
Aufklärender und durchführender Arzt			
Dolmetscher/in (falls erforderlich) – Sprache:			
Zeuge/Zeugin (falls erforderlich)			

Erklärung der Dolmetscherin / des Dolmetschers: Ich habe diesen Bogen und die mündlichen Erläuterungen des Arztes der Patientin / dem Patienten bzw. der gesetzlichen Vertretung vollständig und korrekt in eine für sie verständliche Sprache übersetzt.

FÜR PATIENTINNEN UND PATIENTEN UNTER 18 JAHREN ODER MIT EINGESCHRÄNKTER EINWILLIGUNGSFÄHIGKEIT

Bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren wird die Einwilligung von einem **Elternteil oder dem gesetzlichen Vormund** erteilt. Das Kind wird seinem Alter und seiner Reife entsprechend aufgeklärt, und seine Meinung wird eingeholt. Bei nicht einwilligungsfähigen Patientinnen und Patienten erteilt die gesetzliche Vertretung die Einwilligung.

☐ Sofern wir das Sorgerecht gemeinsam ausüben, erkläre ich, dass der andere Elternteil über diesen Eingriff informiert ist und ihm zustimmt.

☐ Ich erkläre, dass keine gerichtliche Entscheidung und kein Streit über das Sorgerecht / die Vormundschaft besteht (falls doch, wurde dem Arzt das entsprechende Dokument vorgelegt).

Das Kind wurde altersgerecht aufgeklärt; Meinung des Kindes: _____

Dieser Bogen wurde in zwei Exemplaren ausgefertigt: Ein Exemplar verbleibt in der Patientenakte, eines erhält die Patientin / der Patient bzw. die gesetzliche Vertretung.

WIDERRUF DER EINWILLIGUNG (NUR AUSFÜLLEN, WENN SIE SICH ANDERS ENTSCHEIDEN)

Ich widerrufe die oben erteilte Einwilligung. Die möglichen Folgen des Widerrufs wurden mir erklärt.

Name, Unterschrift, Datum und Uhrzeit der widerrufenden Person (Patient/in bzw. Vertreter/in): _____

Dieser Bogen wurde in Übereinstimmung mit der türkischen Patientenrechteverordnung und den Grundsätzen der Türkischen Ärztekammer zur Aufklärung und Einwilligung erstellt. Er ergänzt das mündliche Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt, ersetzt es aber nicht.